

TOC — Trastorno Obsesivo-Compulsivo

ACT — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

En el TOC, ACT conceptualiza el problema como **fusión cognitiva con pensamientos intrusivos** (tratarlos como amenazas reales) y **evitación experiencial** (las compulsiones como intentos de eliminar el malestar). ACT para TOC no reemplaza la ERP pero puede potenciarla, especialmente en pacientes con alta resistencia o TOC refractario. Hay evidencia creciente para ACT como tratamiento complementario o alternativo.

INTERVENCIONES ACT — PASO A PASO

1	Psicoeducación: pensamientos como eventos mentales Los pensamientos intrusivos los tienen todos. El problema no es el pensamiento sino la fusión con él (tomarlo como señal de peligro o de carácter propio). Desafiar la 'Thought-Action Fusion': tener un pensamiento no hace más probable el hecho.
2	Defusión del pensamiento obsesivo Técnicas de defusión aplicadas a obsesiones: 'Estoy notando el pensamiento de que voy a dañar a alguien.' Cantarlo, decirlo muy despacio, ponerle nombre a la historia. Objetivo: reducir la credibilidad del pensamiento sin suprimirlo.
3	Aceptación de la incertidumbre El TOC es intolerancia a la incertidumbre por excelencia. Trabajar estar dispuesto a no saber con certeza. Las compulsiones son intentos de certeza — mostrar que la certeza no se alcanza nunca.
4	Reducción de la fusión con la sobrerresponsabilidad Trabajo con la creencia de que tener un pensamiento implica responsabilidad de actuar. Defusión de las reglas rígidas ('debo asegurarme', 'si no lo chequeo algo malo pasará').
5	Clarificación de valores en el contexto del TOC ¿Qué ha perdido el paciente por el TOC? ¿Qué tipo de vida quiere? Los rituales consumen tiempo y energía que podrían estar al servicio de valores. Hacer visible ese costo.
6	Acción comprometida sin compulsión Equivalente ACT de la prevención de respuesta: comprometerse a actuar desde los valores sin realizar la compulsión, aunque el malestar esté presente. 'Puedo sentir la urgencia de revisar Y elegir no hacerlo porque eso importa más.'

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	ACT especialmente útil en TOC con alta culpa, contenido de daño u obsesiones puras donde la ERP estándar es más difícil de aplicar. También en TOC refractario con historia de tratamientos previos.

TOC — Trastorno Obsesivo-Compulsivo

ACT — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adolescentes	Combinar con psicoeducación familiar. La defusión puede presentarse como 'notar lo que tu cerebro te dice sin tener que hacerle caso'. Trabajo con valores en contexto identitario adolescente.
Niños	ACT para TOC en niños se usa principalmente como complemento. Metáforas concretas: el 'cerebro travieso', la 'máquina de pensamientos'. Involucrar activamente a los padres.

Clave clínica: ACT y ERP son complementarios en TOC: ERP provee la estructura de exposición; ACT provee el marco motivacional y trabaja la fusión que hace la exposición tan difícil. Usar ambos cuando sea posible.